EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91193
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 23-08-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: FELICIANO DEL CARMEN ARAYA SILVA			RUN	: 3.409.310-5
F.Nac	: 23-04-1935	Edad	: 89 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: HOGAR AMOR DE FMLIA STA ROSA NINQUIHUE			Comuna	: CHILLAN
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-07-21	Fecha Egreso	: 23-08-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Neumonia multifocal resuelta
2-ACV isquemico talamo capsular derecho antiguo
3-mioclonias toxico metabolicas
4-sindrome confusional agudo
5-Obs sindrome convulsivo
6-AKI GIII resuelto
7-THE: Hipernatremia mantenida- hipokalemia resuelta
8-antecedentes: HTA, demencia -institucionalizado , hipotiroidismo, dependencia moderada.
9. Hipocalcemia. resuelta.
10. Anemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

NO APORTA INFORMACION. ME REMITO A INFO DE INGRESO MEDICO Y DE ENFERMERIA
PACIENTE DE 89 AÑOS, INSTITUCIONALIZADO DESDE EL AÑO 2022, CON ANTECEDENTES DE HIPOTIROIDISMO, ALZHEIMER, HTA, SEMIDEPENDIENTE, NECESITA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS, ES TRAÍDO POR CUIDADORA DEL HOGAR AL QUE PERTENECE POR CUADRO DE CEG, INAPETENCIA, AUMENTO DE LA DESORIENTACIÓN, PERDIDA DE CONTROL DE ESFÍNTER Y AFASIA DE UN DÍA DE EVOLUCIÓN Y QUE POSTERIOR A ESO PACIENTE SE MANTIENE DEPENDIENTE EN CAMA.
TAC CEREBRAL IMPRESIÓN:
INFARTO SUBAGUDO-CRÓNICO TALAMOCAPSULAR DERECHO. CAMBIOS INVOLUTIVOS ENCEFÁLICOS, ATEROMATOSIS DE VASOS INTRACRANEALES Y MICROANGIOPATÍA DE PREDOMINIO SUPRATENTORIAL.
VIFGIL, AFASICO, QUEJUMBROSO
EX LAB OK, SIN ALZA DE PARAMETROS INFLAMATORIOS
DURANTE SU HOSPITALIZACION PRESENTA MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS, SE EVIDENCIA CRISIS CONVULSIVA FOCAL SIMPLE SECUNDARIAMENTE GENERALIZADA, ES EVALUADO POR NEUROLOGO Y REFIERE MIOCLONÍAS MULTIFOCALES POSTURALES Y DE ACCIÓN, GATILLADAS POR ESTÍMULO AMBIENTAL, DE ORIGEN METABÓLICO-INFECCIOSO (NO EPILÉPTICAS), MANTENGO LVT PARA CONTROL SINTOMÁTICO.
TC CEREBRO S/C DE INGRESO MUESTRA ATROFIA DIFUSA DE PREDOMINIO SILVIANO Y TEMPORAL ANTERIOR BILATERALES, INFARTO ANTIGUO TÁLAMO-CAPSULAR DERECHO, CON FOGGING EN TC CEREBRO SUBSECUENTE, INDICATIVO QUE LESIÓN CON AL MENOS 2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN.
ANGIOTC CEREBRO Y CUELLO SIN ESTENOSIS SIGNIFICATIVAS, SIN SIGNOS DE TVC.
TC DE TÓRAX DESCRIBE PRESENCIA DE NEUMOPATÍA LOBAR INFERIOR IZQUIERDO, CON COMPONENTE ATELECTÁSICO DE PROBABLE ORIGEN ASPIRATIVO, SECRECIONES ENDOLUMINALES QUE OCUPAN CASI LA

TOTALIDAD DEL BRONQUIO FUENTE IZQUIERDO.
POR ANTECEDENTE DE INSTITUCIONALIZACIÓN CAMBIO ESQUEMA ATB.
ACTUALMENTE SIN FIEBRE, SIN SINTOMAS RESPIRATORIOS, SIN CRISIS CONVULSIVA, CON USO DE SNG PARA ALIMENTACION Y SONDA FOLEY
PACIENTE CON ESTADÍA PROLONGADA, SE CONVERSA CON FAMILIAR PEDRO MENDEZ, SOBRE ESTADO DE PACIENTE, PACIENTE CON MANEJO PROPORCIONAL QUE NO SE BENEFICIA DE MAS DIAS HOSPITALIZADO.
SE SUGUIERE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA CONTINUAR KINE RESPIRATORIA, MOTORA, CUIDADOS DE ENFERMERIA Y CONTROLES CON EXAMENES DE LAB PARA EVALUAR ELP.
NO RCP - NO UTI - NO UCI
AL EX FÍSICO: VIGIL, CONFUSO, EN OCASIONES COLABORA HIDRATADO.
CARDIOPULMONAR: RR2T MP +
ABDOMEN CON RHA +, BLANDO, NO DOLOROSO

PLAN DE MANEJO:

Se deriva a Hospitalizacion domiciliaria:
1.- Kine respiratoria y motora
2.- Cuidados de enfermeria y controles de lab para evaluar ELP.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Cambios de posición cada 3hrs, uso de colchon antiescaras
3. Limpieza de cavidad oral
4. Contención sos
5. Agua 500cc c 6hrs por SNG
6. Bromuro ipatropio 2 puff c/6h
7. Manejo con aspiración de secreciones traqueales SOS
8. kine motora y respiratoria
9. LET no RCP NO UPC
10. FAMOTIDINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
11. LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 100 MICROGRAMOS / DOSIS 1 comprimido y 0.5 cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
12. LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
13. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 1 inhalador cada 24 hrs. por 1 dias via INHALATORIA
14. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
15. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
16. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL SOS DOLOR O FIEBRE
17. METOLAZONA COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
18. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
19. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 1 dias via ORAL
20. HIDRALAZINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 1 dias via ORAL
21. POTASIO GLUCONATO FRASCO UNIDAD 20ml x dia por sng
22. CALCIO CARBONATO COMPRIMIDO 1125 MILÍGRAMOS / 175 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 1 dias via ORAL

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXAMENES DE LAB. ACTUAL
Ex de hoy: calcio 8,4, na 156, k 3,70, Cl 126.
LEUCOCITOS 8600
PCR 51 (21/08/24)

OBSERVACIONES:

Continuar Atención en Hospitalización domiciliaria para continuar manejo proporcional.

LUIS MERA SALTOS

JEFE SERVICIO

MEDICO TRATANTE
21510269-6